

Dolor Lumbar Crónico

El diafragma y el control lumbopélvico: un nexo entre las alteraciones del control motor y la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC)

Sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026 · Clínica Sakros, Viña del Mar

Dirigido a kinesiólogos · 12 cupos

Docente: Joaquín Adi — Kinesiólogo y osteópata · Mg. en Terapia Manual Ortopédica · Máster en Functional Training · Máster en Psiconeuroinmunología Clínica · Docente EOM Internacional · Director de Clínica Sakros

En dolor lumbar crónico el modelo tejido-céntrico se queda corto. Hay pacientes que cumplen el programa de ejercicio, progresan en carga y no cambian. No es un problema de dosis ni de adherencia: es un problema de estado del sistema. El paciente sensibilizado no aprende motormente.

El diafragma es el órgano compartido entre la regulación autonómica y el control lumbopélvico. El día 1 se aborda por la vía autonómica; el día 2 por la vía mecánica.
El control motor no se instala mientras el sistema autónomo sigue desregulado.

Metodología

- **12** cupos. Cada participante evalúa, interviene y reevalúa con supervisión directa.
- Cinco bloques prácticos dentro de catorce horas. La teoría sostiene la decisión clínica, no al revés.
- **Razonamiento mecanicista** explícito: se enseña por qué funciona lo que funciona, para poder decidir frente al paciente que no calza con ningún protocolo.
- Estratificación epistémica: se distingue evidencia firme, razonamiento mecanicista e hipótesis en debate, incluidos los estudios que contradicen lo que se enseña.
- Registro objetivo de VFC con Polar H10 y evaluación pre-post en sala.

Programa · Día 1 — sábado 5 de septiembre (8 h)

Horario	Bloque
09:00-10:15	Por qué falla el modelo tejido-céntrico
10:15-11:30	Sistema autónomo y dolor
11:45-13:00	VFC y screening autonómico
14:00-15:45	Práctica 1 · Evaluación del control motor lumbopélvico
16:00-18:00	Práctica 2 · Modulación manual-respiratoria y abordaje diafragmático

Programa · Día 2 — domingo 6 de septiembre (6 h)

Horario	Bloque
09:00-09:45	Del screening al ejercicio
09:45-11:15	Práctica 3 · Transverso abdominal
11:30-13:00	Práctica 4 · Progresiones de control motor
14:00-15:30	Práctica 5 · Patrón de levantamiento
15:30-16:00	Integración

Qué te llevas

- **Protocolo de screening** de control motor lumbopélvico y transverso abdominal, con ficha de registro pre-post lista para usar en consulta.
- **Algoritmo clínico de una página**, impreso y plastificado, para tener sobre el escritorio.
- **Manual completo en PDF**, personalizado con tu nombre.
- **Criterios de progresión y detención** aplicables desde el lunes siguiente.
- Certificado de asistencia.

Sobre qué se sostiene

Búsqueda en PubMed, presentada estratificada. Ejemplos de cada nivel:

EVIDENCIA FIRME	La palpación manual del ADIM es fiable (Valentín-Mazarracín 2021, kappa intra 0,82-1,00). El ejercicio estructurado reduce dolor y limitación funcional con certeza moderada GRADE (Verville 2023, guía OMS).
EVIDENCIA MODERADA	La fiabilidad de los ítems de control motor es aceptable en flexión, pero no en todos los ítems (Thana-Udomnan 2025). El entrenamiento aumenta la razón de contracción del transverso, no su grosor en reposo antes de 12 semanas (Shanbehzadeh 2022).
EN DEBATE	Edad e IMC podrían explicar la alteración del control motor mejor que el dolor (Mikkonen 2025). Palpación, PBU y ecografía no correlacionan entre sí (Prentice 2025). El dolor agudo inducido no alteró el control del movimiento lumbar (Schüssler 2026).

La bibliografía completa con DOI se entrega junto al manual.

Inversión e inscripción

PREVENTA \$290.000 4 cupos · hasta el jueves 6 de agosto	VALOR GENERAL \$360.000 8 cupos · inscripciones hasta el sábado 29 de agosto
--	--

Reserva por WhatsApp: +56 9 6847 7060

Clínica Sakros, Viña del Mar · 12 cupos